

ETAPA 3 — CORRELAÇÕES FUNCIONAIS

◆ EIXO PROGESTERONA

Correlação forte

- irritabilidade
- ansiedade
- compulsão alimentar
- insônia
- TPM intensa
- piora na fase lútea
- sensibilidade emocional
- retenção hídrica

Interpretação

Possível redução de suporte progesterônico e menor efeito gabaérgico na fase lútea.

Racional fisiológico

A progesterona participa:

- da modulação do GABA;
- estabilidade emocional;
- qualidade do sono;
- controle de impulsividade;
- maior tolerância ao estresse.

Oscilações ou queda relativa podem aumentar:

- hiperexcitabilidade neuronal;
 - desejo por carboidratos;
 - pior tolerância glicêmica;
 - despertares noturnos.
-

◆ EIXO PROGESTERONA + GLICÊMICO

Correlação forte

- compulsão por doce
- irritabilidade
- ansiedade no fim do dia
- acordar de madrugada
- insônia
- TPM alimentar
- fome intensa na fase lútea
- oscilação energética

Interpretação

Possível pior tolerância neuroglicêmica associada à fase lútea.

Racional fisiológico

Na fase lútea ocorre:

- aumento da demanda energética;
- maior necessidade serotoninérgica;
- alteração da sensibilidade à insulina;
- maior vulnerabilidade ao cortisol.

Isso pode favorecer:

- hipoglicemia reativa;
 - cravings;
 - despertares noturnos;
 - desregulação de saciedade.
-

◆ EIXO ESTROGÊNICO

Correlação forte

- fluxo intenso
- coágulos
- dor mamária
- edema

- enxaqueca menstrual
- irritabilidade pré-menstrual
- piora da TPM
- sensibilidade emocional

Interpretação

Possível predominância estrogênica relativa.

Racional fisiológico

Maior estímulo estrogênico pode aumentar:

- proliferação endometrial;
- retenção hídrica;
- atividade inflamatória;
- sensibilidade mamária;
- labilidade emocional.

Frequentemente associado a:

- baixa progesterona relativa;
- dificuldade de detoxificação hepática;
- recirculação intestinal de estrogênios.

◆ ESTROGÊNIO + ESTROBOLOMA

Correlação forte

- constipação
- coágulos menstruais
- fluxo intenso
- dor mamária
- distensão abdominal
- acne cíclica
- piora pré-menstrual
- sensação inflamatória

Interpretação

Possível recirculação estrogênica aumentada associada ao eixo intestino-fígado.

Racional fisiológico

Alterações intestinais podem aumentar:

- beta-glucuronidase;
- reabsorção estrogênica;
- sobrecarga hepática funcional.

A constipação é uma das associações MAIS frequentes clinicamente com sintomas de dominância estrogênica.

◆ EIXO GLICÊMICO

Correlação forte

- fome frequente
- compulsão
- sonolência pós-refeição
- dificuldade de emagrecimento
- energia oscilante
- ansiedade alimentar
- acordar de madrugada
- acúmulo abdominal

Interpretação

Possível instabilidade glicêmica e hiperinsulinemia compensatória.

Racional fisiológico

Oscilações glicêmicas podem gerar:

- aumento de cortisol;
- hiperfagia;
- redução de saciedade;
- maior inflamação;
- piora do metabolismo energético.

Clinicamente, costuma coexistir com:

- TPM;
- SOP;
- resistência ao emagrecimento;

- sono fragmentado.
-

◆ EIXO CORTISOL / HPA

Correlação forte

- acordar cansada
- sono leve
- ansiedade
- despertar noturno
- fadiga da tarde
- compulsão noturna
- dificuldade de emagrecimento
- tensão muscular

Interpretação

Possível desregulação do eixo HPA e ritmo cortisol-melatonina.

Racional fisiológico

Disfunções do eixo HPA podem alterar:

- glicemia;
- sono;
- saciedade;
- resposta inflamatória;
- metabolismo tireoidiano e hormonal.

Muito comum em pacientes com:

- sobrecarga emocional;
 - privação de sono;
 - excesso de estímulo;
 - inflamação crônica.
-

◆ PERIMENOPAUSA

Correlação forte

- ciclos espaçando
- calorões
- suor noturno
- insônia
- ansiedade
- oscilação emocional
- pior recuperação
- fadiga
- aumento abdominal

Interpretação

Padrão compatível com transição menopausal.

Racional fisiológico

A perimenopausa cursa com:

- oscilação estrogênica;
- queda progressiva de progesterona;
- maior vulnerabilidade metabólica;
- alterações do sono e termorregulação.

Frequentemente associada a:

- resistência insulínica;
- pior recuperação muscular;
- alterações cognitivas;
- aumento inflamatório.

◆ EIXO ANDROGÊNICO / SOP

Correlação forte

- acne
- oleosidade
- aumento de pelos
- ciclos irregulares
- dificuldade de emagrecimento
- compulsão

- acúmulo abdominal
- queda de cabelo

Interpretação

Possível hiperandrogenismo funcional associado à resistência insulínica.

Racional fisiológico

A hiperinsulinemia pode estimular:

- produção ovariana de andrógenos;
- redução de SHBG;
- maior testosterona livre.

Clinicamente, é muito frequente observar:

- compulsão;
- inflamação;
- acne persistente;
- dificuldade metabólica;
- ciclos anovulatórios.

◆ EIXO INTESTINO + INFLAMAÇÃO

Correlação forte

- distensão abdominal
- constipação
- fadiga
- acne
- dor de cabeça
- névoa mental
- piora alimentar
- sensibilidade intestinal

Interpretação

Possível disbiose e aumento de atividade inflamatória intestinal.

Racional fisiológico

Alterações de microbiota podem impactar:

- metabolismo hormonal;
 - permeabilidade intestinal;
 - inflamação sistêmica;
 - neurotransmissores;
 - saciedade e humor.
-

◆ EIXO TIREOIDEANO FUNCIONAL

Correlação forte

- fadiga
- queda de cabelo
- intestino lento
- frio excessivo
- dificuldade de emagrecimento
- retenção
- baixa energia
- lentificação metabólica

Interpretação

Possível redução adaptativa do metabolismo tireoidiano.

Racional fisiológico

Baixa disponibilidade energética, inflamação e estresse crônico podem impactar:

- conversão T4 → T3;
 - sensibilidade metabólica;
 - termogênese;
 - gasto energético basal.
-

◆ CORRELAÇÕES MAIS PODEROSAS PARA O APP

Se fosse selecionar as MAIS relevantes clinicamente para algoritmo inicial:

1. Progesterona + glicemia
2. Estrogênio + estroboloma
3. Cortisol + sono
4. SOP + resistência insulínica
5. Perimenopausa
6. Tireoide funcional
7. Intestino + inflamação
8. Estrogênio + retenção/inflamação
9. Fase lútea + compulsão
10. Cortisol + despertar noturno

Essas são:

- altamente prevalentes;
- fáceis da paciente identificar;
- fisiologicamente coerentes;
- excelentes para gerar sensação de personalização no aplicativo.